

Sygnały ostrzegawcze

Kiedy warto skierować dziecko do innego specjalisty i jak powiedzieć o tym rodzicom spokojnie, bez straszenia i bez diagnozowania.

Spis treści

1 • Po co ta lista	1
2 • Pilne: od razu do lekarza	2
3 • Sygnały w ruchu	3
4 • Sygnały poza ruchem	4
5 • Jak powiedzieć to rodzicom	5
6 • Kartka obserwacji dla lekarza	6
Następny krok	→

CZĘŚĆ 1

Po co ta lista

Twoja rola to obserwować i informować, a nie diagnozować.

Zajęcia ruchowe wspierają rozwój, ale nie zastępują lekarza ani diagnozy. Ta lista pomaga ci zauważyć, kiedy warto zasugerować rodzicom konsultację, i powiedzieć to spokojnie.

Ważne

To orientacyjna lista sygnałów do obserwacji, a nie narzędzie diagnostyczne. Decyzję o badaniach zawsze podejmują rodzice razem z lekarzem lub specjalistą.

CZĘŚĆ 2

Pilne: od razu do lekarza

Nie czekaj do kolejnej sesji.

CO WIDZISZ	CO ZROBIĆ
Dziecko traci umiejętności, które wcześniej miało (np. przestaje chodzić, mówić).	Poinformuj rodziców tego samego dnia i zasugeruj pilny kontakt z pediatrą.
Nagłe osłabienie lub niesprawność jednej strony ciała.	Przerwij zajęcia, poinformuj rodziców, zasugeruj pilną pomoc lekarską.
Ból podczas ruchu, utykanie, obrzęk.	Przerwij ćwiczenie, poinformuj rodziców, zasugeruj lekarza.
Napad drgawek, utrata przytomności, sinienie.	Wezwij pomoc medyczną (112) i powiadom rodziców.

CZĘŚĆ 3

Sygnały w ruchu

Gdy powtarzają się przez kilka tygodni mimo dostosowań.

CO WIDZISZ	DO KOGO WARTO SKIEROWAĆ (PRZEZ PEDIATRĘ)
Wyraźna różnica między prawą i lewą stroną ciała w sile lub sprawności.	pediatra, fizjoterapeuta dziecięcy, neurolog dziecięcy
Bardzo częste potykanie się i upadki, także na płaskim podłożu.	pediatra, fizjoterapeuta dziecięcy
Chodzenie stale na palcach.	pediatra, fizjoterapeuta dziecięcy
Bardzo wiotkie lub bardzo napięte ciało, nietypowa postawa.	pediatra, fizjoterapeuta dziecięcy
Duża trudność z chwytem i ruchami dłoni w porównaniu z rówieśnikami.	pediatra, terapeuta zajęciowy lub terapeuta integracji sensorycznej
Silna reakcja na dotyk, dźwięki, ruch (unikanie lub ciągłe szukanie).	pediatra, terapeuta integracji sensorycznej
Dziecko często mruży oczy, przechyla głowę, źle ocenia odległość.	pediatra, okulista
Dziecko nie reaguje na polecenia słowne, a reaguje na gesty.	pediatra, laryngolog lub audiolog

CZĘŚĆ 4

Sygnaty poza ruchem

Rzeczy, które zauważysz przy okazji.

CO WIDZISZ	GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA
Mowa wyraźnie mniej rozwinięta niż u rówieśników.	logopeda, poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Trudność w kontakcie i zabawie z innymi, powtarzające się nietypowe zachowania.	pediatra, poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Bardzo silne i częste wybuchy złości, lęk, wycofanie.	psycholog dziecięcy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Ślady, które mogą wskazywać na krzywdzenie dziecka.	Postępuj według procedur swojej placówki; w razie zagrożenia życia 112.

Wskazówka

Zawsze zapisuj obserwacje z datą w «Arkuszu obserwacji». Konkretnie opisy bardzo pomagają lekarzowi.

CZĘŚĆ 5

Jak powiedzieć to rodzicom

Spokojnie, bez straszenia i bez diagnozy.

- 1 Zaczynij od dziecka:** «Bardzo lubię pracować z Zosią. Widzę, jak się stara.»
- 2 Opisz fakt, nie ocenę:** «Zauważyłam, że od kilku tygodni często traci równowagę, także na płaskiej podłodze.»
- 3 Powiedz, co już zrobiłaś:** «Zmieniłam ćwiczenia na łatwiejsze, ale to się powtarza.»
- 4 Zaproponuj krok:** «Myślę, że warto pokazać to pediatrze. On oceni, czy potrzebna jest konsultacja.»
- 5 Zapewnij o współpracy:** «Dalej pracujemy razem. Mogę spisać moje obserwacje, żebyście mieli je dla lekarza.»

Nie mów

«Myślę, że to autyzm / ADHD / porażenie». Nie stawiasz diagnoz. Mów o tym, co widzisz.

CZĘŚĆ 6

Kartka obserwacji dla lekarza

Do wydrukowania i wręczenia rodzicom.

Imię dziecka: _____ Wiek: _____ Okres obserwacji:

DATA	CO ZAUWAŻYŁAM (KONKRETNIE)	W JAKIM ĆWICZENIU	JAK CZĘSTO

Obserwacje z zajęć ruchowych. Nie stanowią diagnozy.

Następny krok

Przejrzyj listę i zaznacz dzieci, przy których coś cię niepokoi. Dla każdego zacznij zapisywać obserwacje z datą.